

14/06/2025
י"ח/סיון/תשפ"ה

דגשים ולקחים רפואיים – מבצע "עם כלביא"

- לתשומת לבכם,
- אירועי תקיפת העורף ביממה החולפת הציבו אתגרים רפואיים ייחודיים בפני צוותי מד"א שכללו: היקף פגיעה משמעותי, מספר רב של נפגעים בתא שטח גדול, קושי בהגעה אל הנפגעים וצורך בהמתנה לחילוץ.
- לאור זאת, מצאנו לנכון לרענן מספר דגשים בניהול הרפואי של מטופלים בזירת נפילה:
1. **פינוי מהיר** - ככלל, יש לפנות את נפגעים מהר ככל האפשר לביה"ח.
 2. **טריאז' –**
 - א. במידה ובזירה כמות נפגעים העולה על יכולות הפינוי הזמינות = יש להקים נקודת ריכוז נפגעים, לבצע טריאז', לסמנם באמצעות תגי מיון ולתעדף פינויים על פי חומרת הפגיעה.
 - ב. יש לשאוף לפינוי של נפגעים דחופים הדורשים טיפול ברמת ALS ע"י צוות אט"ן/בליווי מטפל ברמת ALS עם ציוד מתאים. יחד עם זאת, אין לעכב פינוי של נפגע טראומה דחוף רק לצורך חבירה עם צוות ALS.
 3. **גישה לנפגעים לכודים אך זמינים לטיפול בזירת הרס –**
 - א. יש לטפל בבעיות מסכנות חיים ע"פ A-B-C
 - ב. יש להתחיל טיפול בנוזלים טרם החילוץ / חילץ האיבר:
 - מינון מבוגר – 1 ליטר/שעה
 - מינון ילדים 20 מ"ל/ק"ג/שעה .
 - צוות אט"ן יטפל ע"פ פרוטוקול הטיפול בפגיעת מעיכה.
 - ג. יש לשאוף לפינוי דחוף של מטופל אשר היה לכוד.
 4. **בדיקה גופנית ושלילת פגיעות נוספות –**
 - א. יש לוודא הפשטה /חשיפת חלקי גוף לאיתור פגיעות רסס ומקורות דימום של הנפגעים בזירת נפילה ולכסות את המטופל עם גמר הבדיקה למניעת היפותרמיה ושמירה על צנעת הפרט.
 - ב. חלק מהנפגעים עלולים לסבול מפגיעת הדף, גם ללא סימנים חיצוניים בולטים.
 - ג. יש לבצע בדיקה גופנית לכל נפגע דחק לשלילת פגיעה גופנית.
 5. **קיבוע** - פינוי ע"ג לוח גב והתקנת צווארון תתבצע ע"פ ההתוויות כמופיע באוגדן ותוך התחשבות במנגנון הפגיעה.
 6. **הכרת מוות בזירה** – במידה ומבוצעת ע"י צוות אט"ן – תבוצע רק לאחר השלמת פינוי הנפגעים / ווידוא סד"כ מספק לפינוי הנפגעים מהזירה.
 7. **תיעוד** – יש לוודא מילוי רשומה רפואית לכל נפגע!

אגף רפואה